centre d'urgences pédiatriques et soins spécialisés

FICHE D'INFORMATIONS SUR L'IMMUNOTHÉRAPIE ORALE (ITO)

Comment l'ITO peut aider mes allergies alimentaires ?

Les allergies sont causées par une erreur du système immunitaire ; il perçoit les allergènes (ex : arachides) comme une menace et lui déclare la guerre, alors que l'allergène en soit est inoffensif. L'objectif de l'ITO est de montrer au système immunitaire que l'allergène n'est pas une menace et qu'il n'a donc pas à réagir chaque fois qu'il voit l'aliment. Ce faisant, l'ITO peut réduire le risque de réaction allergique grave (ex. anaphylaxies) lorsque vous êtes exposé à l'aliment auquel vous êtes allergique.

L'ITO est un long processus qui nécessite un suivi médicale serré. Le processus consiste à manger de petites quantités (la dose) de l'aliment tous les jours, en augmentant lentement la dose jusqu'à l'atteinte d'une dose de maintien optimale.

A quelle fréquence sont les rendez-vous avec mon allergologue ?

On peut diviser l'ITO en deux phases :

(1) **Phase d'augmentation** - les visites avec l'allergologue sont aux 6-8 semaines pour augmenter la dose, après quoi il faut rester sous observation en clinique pendant 60 minutes. Entre les visites, le patient continue de prendre cette dose chaque jour à la maison, sous supervision d'un parent. Cette phase dure en moyenne 12-18 mois.
(2) **Phase de maintien** – l'enfant continue de consommer sa dose régulièrement (minimum 3 fois par semaine) et ses visites avec l'allergologue sont moins fréquentes, aux 3 à 12 mois selon son évolution.

Est-ce que l'ITO va guérir mes allergies alimentaires ?

Non, l'ITO ne permet pas de « guérir » les allergies ; l'objectif est que l'enfant soit capable de tolérer une assez grande quantité de l'aliment afin d'être protégé des réactions sévères lors d'éventuelles expositions accidentelles. Environ 80% des enfants atteignent cette protection. Lorsqu'elle est atteinte, l'enfant doit continuer de consommer régulièrement la dose afin de maintenir sa protection. S'il arrête la dose pour quelques semaines/mois, 3 patients sur 4 (75%) vont perdre la protection acquise.

Il y a-t-il des risques ou effets secondaires avec l'ITO ?

Oui, des réactions allergiques peuvent se produire, même avec de petites doses. Le plus souvent, ces réactions ont lieu pendant la phase d'augmentation et sont légères (urticaire, douleur abdominal, démangeaison dans la gorge), mais peuvent aussi inclure des réactions plus importantes (vomissement, crises d'asthme, etc.) et dans de rare cas, même provoquer une anaphylaxie. Les réactions légères se traitent avec des antihistaminiques non sédatifs tels que cétirizine (Réactine); les réactions plus sévères avec un auto-injecteur d'épinéphrine tel que Epipen. Après l'utilisation d'épinéphrine, il faut immédiatement se rendre aux urgences.

Si l'enfant développe de nouveaux symptômes pendant l'ITO, il est important d'en discuter avec l'allergologue.

Faut-il une référence médicale pour discuter de l'ITO avec un allergologue ?

Oui, une référence médicale est requise et un PDF lisible du document doit être téléchargé lors de la prise de rendez-vous dans le programme de soins spécialisé à Saint-Eustache avec une demande en Allergie Pédiatrique.